第一章 中医学理论体系

一、 “最早、第一部”典籍

名称	类型
《黄帝内经》	最早的医学文献典籍
《伤寒杂病论》	第一部辨证论治的专著
《神农本草经》	最早的中药学专著
《脉经》	第一部脉学专著
《针灸甲乙经》	第一部针灸学专著
《诸病源候论》	第一部病因病机学专著
《千金要方》	第一部医学百科全书

金元四大家以及所代表的派别分别是：张从正“攻邪派”、李杲“补土派”、刘完素“寒凉派”、朱丹溪“滋阴派”。

二、 中医基础理论体系主要特点：整体观念、辨证论治

三、 古文类总结

1. 春日浮，如鱼之游在波；夏日在肤，泛泛乎万物有余；秋日下肤，蛰虫将去；冬日在骨，蛰虫周密。
2. 春弦夏洪，秋毛冬石。
3. 春生、夏长、秋收、冬藏。
4. 夫百病者，多以旦慧，昼安，夕加，夜甚……朝则人气始生，病气衰，故旦慧；日中人气长，长则胜邪，故安；夕则人气始衰，邪气始生，故加；夜半人气入藏，邪气独居于身， 故甚也。
5. 平旦人气生，日中而阳气隆，日西而阳气已虚，气门乃闭。
6. 春善病鼽衄，仲夏善病胸胁，长夏善病洞泄寒中，秋善病风疟，冬善病痹厥。
7. 用凉远凉，用寒远寒，用温远温，用热远热。
8. 西北之气散而寒之，东南之气收而温之。

四、 辨证论治

1. 病：完整的异常生命过程，如感冒、胸痹、消渴、积聚等。
2. 证：是疾病中某一阶段或某一类型的病理概括，如风寒表证、脾胃虚弱证等。
3. 症：症状和体征的总称，如恶寒发热、恶心呕吐、头痛、舌苔、脉象等。

微信17363473306

第二章 精气学说

精气学说的概念：精气是充塞宇宙之中的无形[指肉眼看不见形质]而运动不息的极细微物质，是构成宇宙万物的本原。精源于水地说，气源于云气说。

第三章 阴阳学说

一、 阴阳的概念

1. 阴阳：是对自然界相互关联的某些事物和现象对立双方属性的概括。
2. 事物阴阳属性的绝对性和相对性。
3. “天地者，万物之上下也；阴阳者，气血之男女也；左右者，阴阳之道路也；水火者， 阴阳之征兆也；阴阳者，万物之能始也”。

二、阴阳分属

昼为阳	上午为阳中之阳；下午为阳中之阴	夜为阴	前半夜为阴中之阴
			后半夜为阴中之阳
背为阳	阳中之阳，心也；阳中之阴，肺也	腹为阴	阴中之阴，肾也
			阴中之阳，肝也
			阴中之至阴，脾也

药性	阴	阳
四气	寒、凉	热、温
五味	酸、苦、咸	辛、甘、[淡]
升降浮沉	沉、降	升、浮

三、阴阳学说的主要内容

1. 阴阳对立制约

（1） 动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳。

（2） 阴胜则阳病，阳胜则阴病；阳虚则阴盛，阴虚则阳亢；阳虚则寒，阴虚则热。

（3） 益火之源，以消阴翳；壮水之主，以制阳光。2.

阴阳互根互用

（1） 阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也；阴中求阳，阳中求阴。

（2） 孤阴不生，独阳不长；阳生阴长，阳杀阴藏。

（3） 阴损及阳，阳损及阴；阴阳离决，精气乃绝。

（4） 阴者，藏精而起亟也，阳者，卫外而为固也。

（5） 阴阳一分为二，合二为一→互根。

微信17363347306

2. 阴阳交感互藏

（1） 宇宙万物赖以生成和变化的根源→交感。

（2） 阴中有阳，阳中有阴。

（3） 阴阳消长与转化的内在根据→互藏。

（4） 天地感而万物化生。

（5）本乎天者亲上，本乎地者亲下；地气上为云，天气下为雨，雨出地气，云出天气。

3. 阴阳消长平衡[量变]

（1） 对立制约：阴阳互为消长。

（2） 互根互用：阴阳皆消皆长。

4. 阴阳相互转化[质变]

（1） 四时之变，寒暑之胜，重阴必阳，重阳必阴，故阴主寒，阳主热，故寒甚则热， 热甚则寒。

（2） 故曰：寒生热，热生寒，此阴阳之变也。

四、阴阳学说在中医学中的应用

1. 病理

（1） 阴阳偏盛[实证]：阳胜则热，阴胜则寒；阳胜则阴病，阴胜则阳病。

（2） 阴阳偏衰[虚证]：阳虚则寒，阴虚则热。

（3） 阴阳互损：阳损及阴；阴损及阳。2.

治疗

（1） 阴阳偏盛者损其有余用“实则泻之”的原则治疗。

（2） 阳偏衰导致的虚寒证，采用阴病治阳：益火之源，以消阴翳[阴中求阳]。

（3） 阴偏衰导致的虚热证，采用阳病治阴：壮水之主，以制阳光[阳中求阴]。

（4） 阴阳互损导致的阴阳两虚：阴阳双补。

★青竹助攻：“壮谁谁虚”、“益谁谁虚”、“治谁谁虚”、“取谁谁虚”、“求谁谁虚”。

微信17363347306

第四章 五行学说

一、 五行的概念

五行	特征	引申义
木	木曰曲直	生长、升发、条达、舒畅
火	火曰炎上	温热、上升、光明
土	土爰稼穑	生化、承载、受纳
金	金曰从革	沉降、肃杀、收敛、变革
水	水曰润下	滋润、下行、寒凉、闭藏

二、五行归类

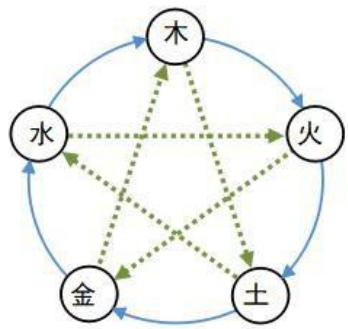
1. 方法/原则：取象比类法、推演络绎法。
2. 五行归类表。

自然界							五行	人体							
五音	五味	五色	五化	五气	方位	季节		五脏	五腑	五官	形体	情志	五声	变动	五华
角	酸	青	生	风	东	春	木	肝	胆	目	筋	怒	呼	握	爪
徵	苦	赤	长	暑	南	夏	火	心	小肠	舌	脉	喜	笑	忧	面
宫	甘	黄	化	湿	中	长夏	土	脾	胃	口	肉	思	歌	哕	唇
商	辛	白	收	燥	西	秋	金	肺	大肠	鼻	皮	悲	哭	咳	毛
羽	咸	黑	藏	寒	北	冬	水	肾	膀胱	耳	骨	恐	呻	栗	发

三、五行学说的主要内容

1. 五行的生克。

【说明】①相生；②相克。



2. 五行的制化。
3. 母子相及与五行乘侮。

（1） 母病及子→病轻→邪挟生气而来，则虽进而易退。

（2） 子病及母→病重→受我之气者，其力方旺，还而相克，来势必甚。

（3） 相乘传变→病重→脏气本已相制，而邪气挟其力而来，残削必甚，故为贼邪。

（4） 相侮传变→病轻→脏气既受制于我，则邪气亦不能深入，故为微邪。

四、五行学说在中医学中的应用

五行关系	治法治则	
五行相生	虚则补其母 实则泻其子	滋水涵木：滋肾阴以养肝阴[肝阳上亢]
		益火补土：温肾阳以补脾阳
		培土生金：健脾气以补肺气
		金水相生：兼养肺肾之阴
五行相克	抑强扶弱	抑木扶土：疏肝气以健脾胃
		培土制水：健脾土以利水湿
		佐金平木：滋肺阴以清肝火
		泻南补北：泻心火以补肾水[心肾不交]

★“怒胜思”、“思胜恐”、“恐胜喜”、“喜胜忧”、“悲胜怒”。

微信17363477306

第五章 藏象学说

1. 藏象及藏象学说的概念与特点。
2. 藏象学说形成的基础。
3. 五脏、六腑、奇恒之腑的分类[增]。

（1） 所谓五脏者，藏精气而不泻也，故满而不能实。

（2） 六腑者，传化物而不藏，故实而不能满也。

（3） 奇恒之腑形态上中空有腔与六腑相类，机能上贮藏精气与五脏相同，与五脏和六腑都有明显区别。

一、 五脏

1. 五脏的生理功能与特性

五脏	别称	功能
心	君主之官、生之本、火脏、五脏六腑之大主	主血脉、心藏神
肺	相傅之官、华盖、娇脏	主气司呼吸、主行水、朝百脉主治节
脾	仓廪之官、孤脏、后天之本、气血生化之源	主运化、主统血 [与血液生成关系最密切]
肝	将军之官、刚脏、罢极之本	主疏泄[调畅全身气机]、主藏血
肾	作强之官、先天之本、水脏、封藏之本、胃之关、五脏阴阳之本	主藏精、主水、主纳气[呼吸保持一定深度]，[最易发生阴阳互损]

★心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志。2.

原文

（1） 女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下， 故有子；三七，肾气平均，故真牙生而长极；四七，筋骨坚，发长极，身体盛壮；五七，阳明脉衰，面始焦，发始堕；六七，三阳脉衰于上，面皆焦，发始白；七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。[五六七，阳三太]

（2） 丈夫八岁，肾气实，发长齿更；二八，肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子；三八，肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极；四八，筋骨隆盛，肌肉满壮；五八， 肾气衰，发堕齿槁；六八，阳气衰竭于上，面焦，发鬓颁白；七八，肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆极；八八，则齿发去。[五六七，肾阳衰]

3. 五脏关系

（1） 心与其他四脏的关系

肺	气血互用→心主血，肺主气，血行依赖气的推动 呼吸吐纳→宗气贯心脉而司呼吸
脾	血液生成→心主血，脾生血 血液运行→心主行血，脾主统血

微信17363477306

肝	血液运行正常→心主血，肝藏血[储藏血液，调节血量] 精神情志→心主神志，肝主疏泄
肾	水火既济→心火下济于肾，使肾水不寒；肾水上济于心，使心火不亢 精神互用→心藏神；肾藏精 君相安位→心为君火，肾为相火，二者各安其位

（2）肺与其他三脏的关系

脾	气的生成→肺为主气之枢，脾为生气之源 津液代谢→肺气宣降主行水，脾气散精主运化
肝	气机升降→肝升肺降→龙虎回环→调节全身气机 气血运行→肺主气，肝藏血
肾	津液代谢→①肺→主行水，为水之上源；②肾→水脏，主水 呼吸运动→①肺→司呼吸；②肾→主纳气→肺为气之主，肾为气之根 阴阳互资→金水相生

（2） 肝与其他两脏的关系

脾	疏泄与运化互用→肝主疏泄；脾主运化 藏血与统血协调→肝主藏血，调节血量；脾为气血生化之源，统摄血液
肾	精血同源→肝藏血，肾藏精，精血同源于水谷精微，且能相互转化资生。[乙癸同源] 藏泄互用→肝主疏泄，肾主封藏，二者之间存在着相互制约、相互为用的关系 阴阳互滋互制→①肾阴→[滋养]肝阴→肝阳不亢；②肾阳[命门之火]→[资助]肝阳→肝脉不寒

（3） 脾与肾的关系

先天后天相互资生	脾主运化，化生气血，为后天之本；肾主藏精，是生命之本原，为先天之本
津液代谢	脾肾两脏相互协同，共同主司津液代谢的协调平衡

二、六腑

1. 六腑的生理功能

六腑	别称	功能
胆[肝]	中正之官、中精之府、清净之府、中清之府	贮藏和排泄胆汁、主决断
胃[脾]	太仓、仓廪之官、水谷之海、水谷气血之海	受纳和腐熟水谷[喜润恶燥]
小肠[心]	受盛之官	受盛化物、泌别清浊、主液
大肠[肺]	传导之官	传化糟粕、主津[燥化作用]
膀胱[肾]	州都之官、津液之府	汇聚水液、贮存和排泄尿液
三焦	孤府、决渎之官	通行元气、运行津液

微信17363347306

2. 六腑与五脏的关系

（1） 心与小肠

生理状态	心主血脉，心阳温煦，心血濡养→助小肠化物
	小肠化物，泌别清浊→清者经脾上输心肺，化赤为血，以养心脉
病理状态	心经实火，移热小肠→“小肠火”
	小肠有热，上熏于心→心烦、舌赤糜烂等
	小肠虚寒，化物失职→水谷精微不生→日久可出现心血不足

（2）肺与大肠

生理状态	肺气肃降→推动大肠传导糟粕
	大肠传导功能正常，糟粕下行→有助于肺气肃降
病理状态	肺气壅塞，失于肃降→腑气不通→肠燥便秘
	大肠实热→传导不畅→腑气阻滞→肺气宣肃失常→胸满咳喘等

（3）脾与胃

水谷纳运协调	生理状态	胃主受纳腐熟水谷→为脾主运化提供前提	
		脾主运化，消化水谷，传输精微→满足胃继续受纳需求	
	病理状态	脾失健运→胃纳不振	→脾胃纳运失调→纳少腹胀等
		胃气失和→脾运失常	
气机升降相因	生理状态	脾胃居于中焦→脾主升，胃主降→脏腑气机上下升降的枢纽	保证纳运正常
			维护内脏位置恒定
		脾气上升→向上→	输布运化吸收的水谷精微
			有助于胃气之升降
		胃气通降→下行→	收纳之水谷、食糜及食物残渣
			有助于脾气之升运
	病理状态	脾虚气陷→胃失和降→胃气上逆	→气机升降失常
		胃失和降→脾气失运失常	
阴阳燥湿相济	生理状态	脾为阴脏→喜燥而恶湿；脾易生湿，得胃阳以制之，使脾不至于湿	
		胃为阳腑→喜润而恶燥；胃易生燥，得脾阴以制之，使胃不至于燥	
		脾胃阴阳燥湿相济，是保证两者纳运、升降协调的必要条件	
	病理状态	湿困脾运→胃纳不振	脾湿则其气不升，胃燥则其气不降→中满痞胀，排便异常等症
		胃阴不足→影响脾运	

（4）肝与胆

同司疏泄	生理状态	肝主疏泄，分泌胆汁→肝气疏泄正常→促进胆汁的分泌和排泄	
		胆附于肝，藏泄胆汁→胆汁排泄无阻→有利于肝气疏泄的正常发挥	
	病理状态	肝气郁滞→胆汁疏利[×]	→肝胆气滞、肝胆湿热，或郁而化火、肝胆火旺
		胆腑湿热→肝气疏泄[×]	
共主勇怯	生理状态	胆主决断	
	病理状态	肝胆疏泄失常→[肝气郁滞][胆郁痰扰]→情志抑郁、失眠多梦等	

微信17363347306

（2） 肾与膀胱

生理状态	肾为主水之脏，生成尿液，开窍于二阴	肾与膀胱相互协作，共同完成尿液的生成、贮存与排泄
	膀胱主贮藏尿液，自前阴排出	
病理状态	肾气虚弱➞[蒸化无力][固摄无权]➞膀胱贮尿、排尿失常一尿少、癃闭等	
	[膀胱湿热][膀胱失约]➞影响肾气蒸化/固摄➞尿液及排泄异常	

三、奇恒之腑

1. 概念：包括脑、髓、骨、脉、胆、女子胞六个脏器组织。2.

脑

（1） 别称：髓海、元神之府、精神之海。

（2） 生理功能

<1> 主宰生命活动：“脑为元神之府”，是生命的枢机。

<2> 主宰精神活动：人的意识、思维、情志等精神活动。

<3> 主感觉活动：口、舌、眼、鼻、耳五官诸窍，皆位于头面，与脑相通，其视、听、言、动等机能，皆与脑密切相关。

3. 女子胞

（1） 别称：胞宫、子宫、子脏、胞脏、子处、血脏。

（2） 生理功能

<1> 主持月经。

<2> 孕育胎儿。4.

与脏腑经脉的关系

<1> 脏腑：心➞主血脉；肝➞藏血；脾➞统血、气血生化之源；肾➞藏精；肺➞朝百脉。

<2> 经脉：冲➞血海、五脏六腑之海、十二经之海；任➞阴脉之海；督➞阳脉之海；带➞约束冲、任、督。

第六章 精、气、血、津液、神

一、 精

1. 生成：人体之精=先天之精+后天之精。

2. 人体之精的分类与功能

（1） 分类：先天之精、后天之精、生殖之精、脏腑之精。

（2） 功能：繁衍生命、濡养、化气、化血、化神、抗邪。

二、气

1. 气的生理功能

（1） 推动调控作用；

微信17363347306

（2） 温煦凉润作用；

（3） 防御作用；

（4） 固摄作用；

（5） 中介作用；

（6） 营养作用。

★与气生成相关的脏腑：肾为生气之根，脾胃为生气之源，肺为生气之主。2.

人体之气的分类

元气	人体最根本最重要的气，人体生命活动的原动力	
	生成	先天之精化生，水谷之精充养
	分布	根于命门，以三焦为通路，循行全身，内而五脏六腑，外而肌肤腠理，无处不到
	功能	推动和调节人体的生长发育和生殖机能
		推动和调节各脏腑、经络、形体、官窍的生理活动
宗气	汇聚于膻中➞“气海”	
	生成	水谷之气+自然界清气
	分布	聚于胸中，通过上出息道；贯注心脉及沿三焦下行的方式布散全身；下注于气街，并下行于足
	功能	上走息道，推动肺的呼吸；贯注于心脉之中，促进心脏推动血液运行；对先天元气有资助作用；与语言、声音、呼吸强弱有关
营气	生成	水谷精微中的精华
	分布	行于脉中，循脉运行全身，内入脏腑，外达肢节，终而复始，营周不休
	功能	化生血液；营养全身
卫气	生成	水谷精微中剽悍滑利部分
	分布	行于脉外，不受脉道束缚，外而皮肤肌腠，内而胸腹脏腑，布散全身
	功能	抵御外邪；温养全身；调节腠理

三、血

1. 生成：水谷之精和肾精[营气+津液+肾精][相关脏腑：心、肺、肾、脾胃]。2.

功能

（1） 营养和滋润作用：“血主濡之”。

（2） 血是机体精神活动的主要物质基础：“血脉和利，精神乃居”。3.

运行

影响因素➞相关脏腑➞心、肝、脾、肺

（1） 气的推动与宁静、温煦与凉润的平衡；

（2） 气的固摄；

（3） 脉道完好与畅通；

（4） 血液的清浊与粘稠；

微信17634306

加马老师微信15538955609领取模拟卷、各种总结！！

（5） 血的寒热；

（6） 阴阳邪气。

四 、津液

1. 津与液的鉴别

津	阳	质地清稀	流动性大	布散于皮肤、肌肉、孔窍	滋润作用
液	阴	质地稠厚	流动性小	布散于骨节、脏腑、脑、髓	濡养作用

2. 生成来源：饮食水谷。

3. 生成相关脏腑：脾、胃、小肠、大肠。

4. 输布

（1） 肺通调水道而行水。

（2） 脾气散精以输布津液。

（3） 肾气蒸腾气化水液。

（4） 肝调畅气机以水行。

（5） 三焦决渎利水道。

5. 排泄脏腑：肺脾肾[最主要]。

二、 神

1. 生成基础：气血津液。

2. 五神：神、魂、魄、意、志。

3. 情志

（1） 七情：怒、喜、忧、思、悲、恐、惊。

（2） 五志：心在志为喜，肝在志为怒，肺在志为忧，脾在志为思，肾在志为恐。

三、 精气血津液神之间的关系。

1. 气与血

气为血之帅→	气能生血 气能行血 气能摄血	血为气之母→	血能养气 血能载气

2. 气与津液

气	气能生津；气能行津；气能摄津
津	津能载气；津能化气

3. 精血津液

精血同源[肝肾同源]	精可化血；血以养精
津血同源	夺血者无汗，夺汗者无血；衄家不可发汗；亡血家不可发汗

微信17363347306

加马老师微信15538955609领取模拟卷、各种总结！！

4. 精气神

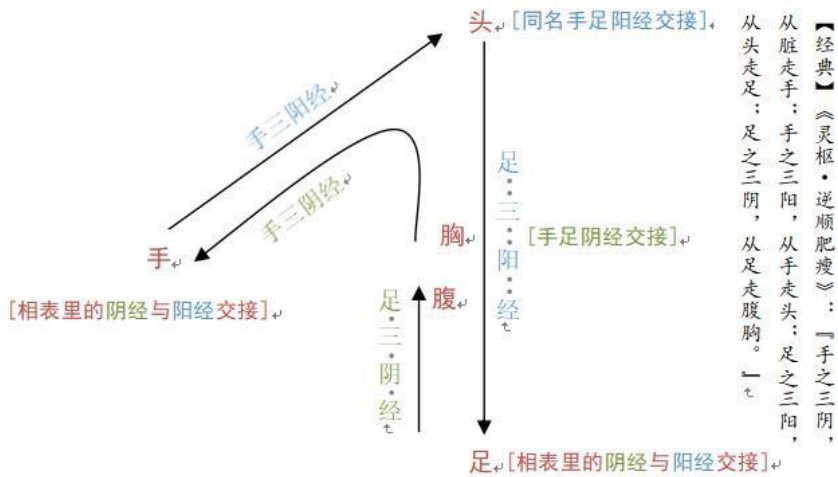
气	气能生精；气能摄精
精	精能化气；精神互用
神	神气互生

第七章 经络

一、 十二经脉名称

	阴经[属脏络腑]	阳经[属腑络脏]	分布部位[阴经行内侧，阳经行外侧]	
手	太阴肺经	阳明大肠经	上肢	前缘
	厥阴心包经	少阳三焦经		中线
	少阴心经	太阳小肠经		后缘
足	太阴脾经	阳明胃经	下肢	前缘
	厥阴肝经	少阳胆经		中线
	少阴肾经	太阳膀胱经		后缘
[注]在小腿下半部和足背部，肝经在前缘，脾经在中线。在内踝尖上八寸处交叉后，脾经在前缘，肝经在中线				

二、经络循行走向



节选自《中综知要》

三、十二经脉交接规律

1. 相表里的阴阳经在四肢末端交接。
2. 同名手足阳经在头面部交接。
3. 同名手足阴经在胸中交接。

四、十二经脉流住次序

肺大胃脾心小肠，胱肾包焦胆肝镶。食鼻足大心小指，目内足小胸无名，目外足大厥阴肝。

加马老师微信15538955609领取模拟卷、各种总结！！

五、其他

足三阴经的循行：内踝尖上八寸以下为厥阴在前，太阴在中，少阴在后；内踝尖上八寸以上则是太阴在前，厥阴在中，少阴在后。

循行于胸腹部的经脉，自内向外依次为足少阴肾经、足阳明胃经、足太阴脾经和足厥阴肝经。

第八章 病因、发病、病机、防治原则

一、 六淫

六淫各自的性质及致病特点[外感性、季节性、地域性、相兼性]			
风邪	①风为阳邪，轻扬开泄，易袭阳位 ②风性善行而数变 ③风性主动 ④风为百病之长[常兼他邪合而伤人]	寒邪	①寒为阴邪，易伤阳气 ②寒性凝滞主痛 ③寒性收引
暑邪	①暑为阳邪，其性炎热 ②暑性升散，易扰心神，伤津耗气 ③暑多挟湿	湿邪	①湿为阴邪，易伤阳气，易阻气机 ②湿性重浊 ③湿性黏滞 ④湿性趋下、易袭阴位
燥邪	①燥性干涩，易伤津液 ②燥易伤肺	火邪	①火热为阳邪，其性燔灼趋上 ②易扰心神 ③易伤津耗气 ④易生风动血 ⑤易致阳性疮痈

二、情志内伤

1. 最易损伤的脏腑：心肝脾。
2. 损伤脏腑气机：怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，惊则气乱，思则气结。

三、劳逸

1. 劳神过度易耗伤心血，损伤脾气。
2. 久视伤血，久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋。

四、痰饮、瘀血

1. 痰饮形成的相关脏腑：肺脾肾肝三焦。
2. 痰饮的致病特点：阻滞气血运行；影响水液代谢；易于蒙蔽心神；致病广泛，变化多端。
3. 瘀血的致病特点：易于阻滞气机；影响血脉运行；影响新血生成；病位固定，病证繁多。

微信17363475306

加马老师微信15538955609领取模拟卷、各种总结！！

4. 瘀血的症状特征：疼痛；肿块；出血；色紫暗；可出现肌肤甲错，面色黧黑；脉涩或结代。

五、邪正盛衰--虚实变化

虚实错杂	虚中夹实；实中夹虚
虚实真假	真虚假实➞至虚有盛候；真实假虚➞大实有羸状

六、阴阳失调

1. 阴阳盛衰

阴阳偏盛	阳偏盛	阳盛而阴未虚的实热证➞热、动、燥
	阴偏盛	阴盛而阳未虚的实寒证➞寒、静、湿
阴阳偏衰	阳偏衰	阳气不足，阴气相对偏亢的虚寒证→喜静蜷卧，脉微细
	阴偏衰	阴气不足，阳气相对偏盛的虚热证→潮热，盗汗，脉细数

2. 阴阳互损

[阴损及阳][阳损及阴] 无阴则阳无以生，无阳则阴无以化	➞阴阳两虚

3. 阴阳格拒

阴盛格阳	阴盛于内，格阳于外	真寒假热证
阳盛格阴	阳盛于内，格阴于外	真热假寒证

4. 阴阳亡失

亡阳	冷汗淋漓、心悸气喘、面色苍白、四肢逆冷、畏寒蜷卧、精神萎靡、脉微欲绝等生命垂危之象
亡阴	手足虽温而大汗不止、烦躁不安、心悸气喘、体倦无力、脉数疾躁动等危重征象

5. 正气不足是疾病发生的基础；邪气是发病的重要条件。

二、 精气血的失常

1. 气机失常

气滞	气的运行不畅，或郁滞不通的病理变化；肺肝脾胃多见
气逆	气升之太过，或降之不及，以致气逆于上的一种病理变化；肺肝胃多见
气闭	气机闭阻，失于外达，甚至清窍闭塞，出现昏厥的一种病理变化
气脱	气虚至极，不能内守而大量脱失以致生命机能突然衰竭的一种病理变化
气陷	气的上升不足或下降太过，以气虚升举无力而下陷为特征的一种病理变化

2. 血的失常

（1） 血虚:生成不足；损耗过多。

微信17363475906

加马老师微信15538955609领取模拟卷、各种总结！！

（2） 血运失常：血瘀、血寒、血热、出血。

（3） 血瘀:血寒、血热、痰浊、瘀血、气滞、气虚。

（4） 出血:血热、气虚、外伤。3.

精、气、血的关系失调

气滞血瘀	情志内伤；跌打闪挫[外伤]→刺痛、瘀块、紫暗、瘀斑、肌肤甲错、脉涩等
气虚血瘀	气对血推动无力→喘促、水肿、半身不遂等
气不摄血	中气不足；气虚下陷→各种出血证
气随血脱	各种大出血→眩晕、大汗、四肢厥冷、脉芤或微细等
气血两虚	久病耗伤；气虚；失血→面色淡白、少气懒言、疲乏无力、肌肤干燥等
气血不荣经脉	气血虚衰；气血失和→肢体麻木、运动不便、皮肤干燥、瘙痒、肌肤甲错等

4.津液代谢失常

（1） 津液不足：指津液亏损，脏腑组织失于滋养，表现一系列干燥枯涩征象的病理变化。

（2） 津液输布障碍：肺失宣发和肃降、脾失健运、肝失疏泄、三焦水道不利。

（3） 津液排泄障碍：汗→肺气的宣发功能失常；尿→肾气的蒸化作用失常[主导作用]。

三、 防治原则

1. 正治与反治

（1） 正治[逆治→逆证而治]→寒者热之、热者寒之、虚则补之、实则泻之。

（2） 反治[从治→顺证而治]→热因热用、寒因寒用、塞因塞用、通因通用。

2. 治标治本。

3. 扶正祛邪。

4. 三因制宜。

微信17363473306

加马老师微信15538955609领取模拟卷、各种总结！！

微信17363473306